Boletin Epidemiologico Municipio de Pereira

Índice

1 Eventos Trazadores **1**
1.1 Infección respiratoria aguda . . . 1
1.2 Circulación virus respiratorios . . . 4
1.3 Enfermedades transmitidas por vectores . . . 5
1.4 Infección Diarreica Aguda . . . 6

2 Eventos de interes en salud pública **6**
2.1 Mortalidad materno-perinatal . . . 6
2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia . . . 6
2.3 Tuberculosis . . . 6
2.4 VIH/SIDA . . . 6
2.5 Sìfilis gestacional y congénita . . . 6
2.6 Cáncer . . . 6
2.7 Defectos congénitos . . . 8
2.8 Inmunoprevenibles . . . 8
2.9 Virus nuevo (COVID-19) . . . 8

3 Vigilancia de exantematica **8**
3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales . . . 8

1 Eventos Trazadores

1.1 Infección respiratoria aguda

A semana epidemiológica 14 de 2026 se notificaron un total entre consultas externa/urgencias hospitalizaciones en sala y hospitalizaciones en UCI de 691907 de las cuales el 2.9% (n= 20031) corresponden a IRA. El canal endémico muestra el evento para la semana 14 bajo el umbral estacional.

En relación a la notificación segun servicio y comparando la semana notificada del actual año con la misma semana del año anterior, se identifica un aumento en el servicio de hospitalización UCI.

Tabla 1. Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda segun tipo de servicio, semana epidemiológica 14

Servicio	a Sem 14/2025	a Sem 14/2026	Variacion (%)
Hospitalización Sala	1131	803	-29
Hospitalizacion UCI	131	112	-14.5
Consulta Externa-Urgencias	22949	19116	-16.7

Para la semana 14 la hospitalización por IRA en sala general se reporta por encima del umbral estacional, en una zona de brote. Datos que seran verificados para la proxima semana epidemiologica. La proporción acumulada de

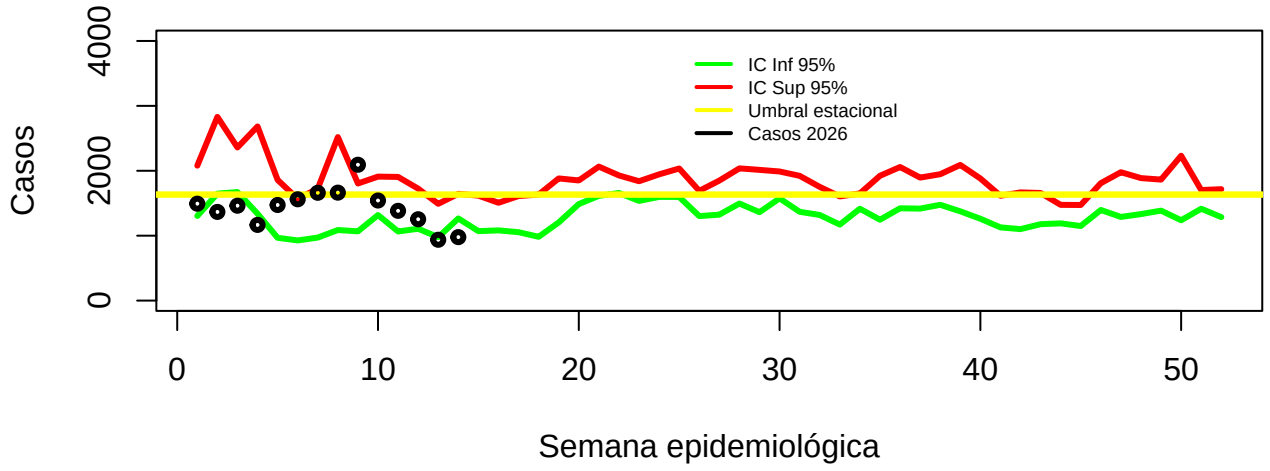


Figura 1: Canal endémico IRA , Pereira 2026 semana epidemiologica 14

hospitalización por IRA es de 3.56%.

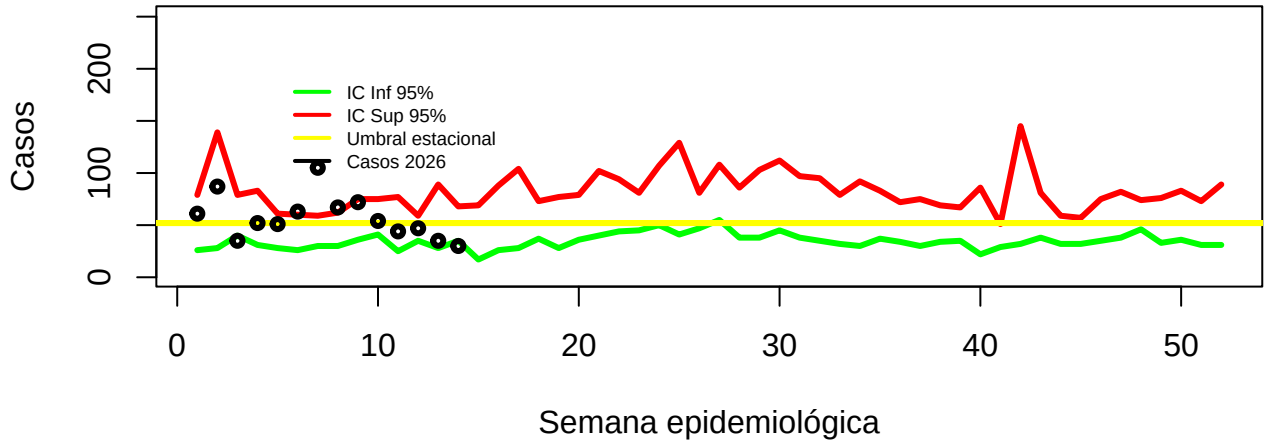


Figura 2: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en sala general , Pereira 2026

De igual manera en el canal endémico para la notificación por IRA hospitalizados en Unidad de Cuidados Intensivos (**UCI**) (figura 3), se encuentra sobre el umbral estacional esperado. La proporción acumulada de hospitalizaciones por IRA en UCI alcanza un 3.36%.

Edad (años)	Hosp. UCI IRA	Hosp. UCI todas las causas	% de Hosp. UCI
< 1	3	50	6
1	2	4	50
2 a 4	0	7	0
5 a 19	0	20	0
20 a 39	0	19	0

Edad (años)	Hosp. UCI IRA	Hosp. UCI todas las causas	% de Hosp. UCI
40 a 59	0	26	0
mayor e igual 60	0	92	0

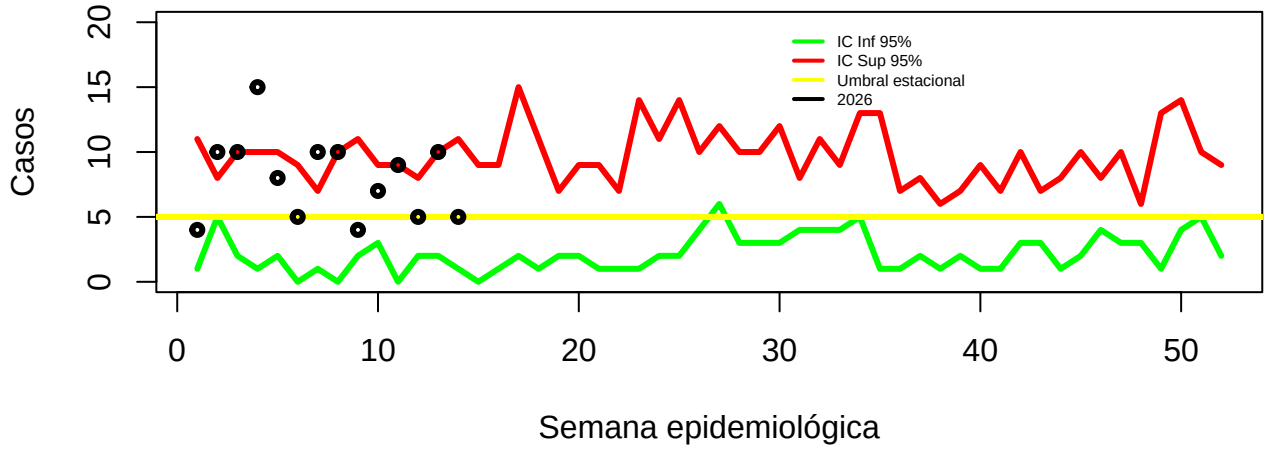


Figura 3: Canal endémico Hospitalizaciones por IRA en UCI , Pereira 2026

Por grupo de edad en la hospitalizaciones por IRA, la mayor concentración de hospitalizaciones a causa de infección respiratoria esta en el grupo menor a 5 años.

Edad (años)	Hospitalizaciones IRA	Hospitalizacion todas las causa	% de Hospitalizaciones
< 1	4	74	5.4
1	3	5	60.0
2 a 4	0	16	0.0
5 a 19	5	105	4.8
20 a 39	5	338	1.5
40 a 59	1	230	0.4
mayor e igual 60	12	433	2.8

En consulta externa y urgencias se han reportado de manera acumulada 666024 de consultas, donde las consultas por infección respiratoria aguda ocupan el 2.87%.

En cuanto a la edad, en las consultas por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, la proporción de consultas por IRA en cada grupo de edad se muestra en la tabla. El canal endemico general para IRA esta en el umbral estacional en zona de brote.

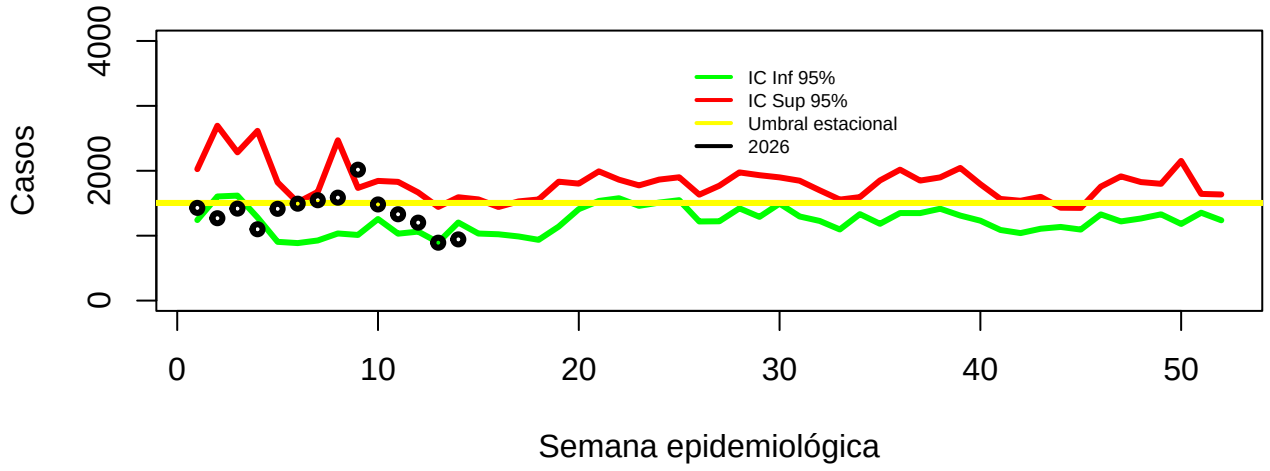


Figura 4: Canal endémico consulta externa y urgencias por IRA, Pereira 2026

Edad (años)	Consultas IRA	Consulta todas las causa	% de Consultas
< 1	73	619	11.8
1	36	417	8.6
2 a 4	88	1,098	8.0
5 a 19	115	3,863	3.0
20 a 39	259	10,323	2.5
40 a 59	173	11,731	1.5
mayor e igual 60	199	17,069	1.2

1.2 Circulación virus respiratorios

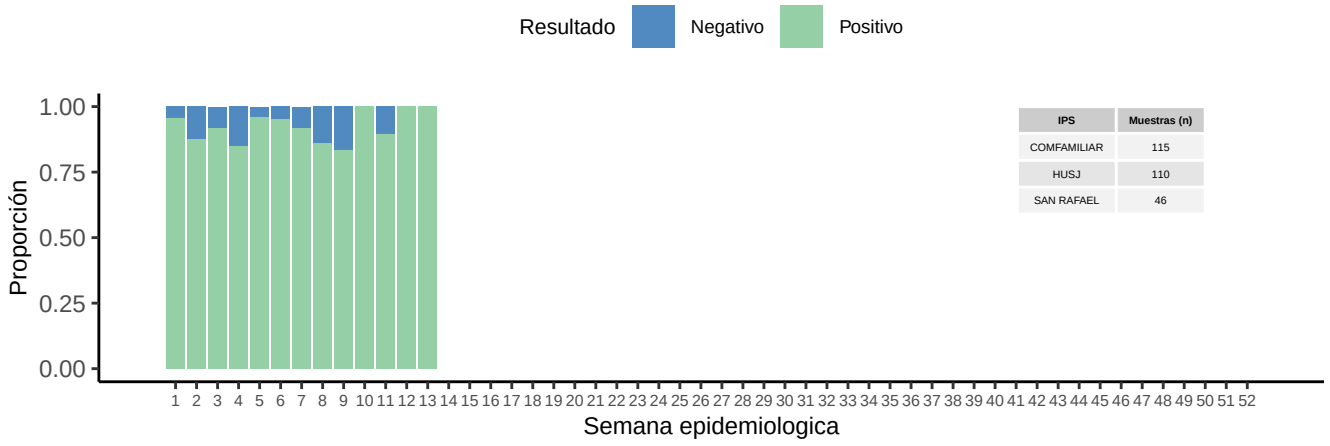


Figura 5: Positividad muestras tracto respiratorio, Pereira 2026

A periodo epidemiologico 4 de 2026 271 muestras en el municipio, con aislamientos tanto virales como bacterianos con una positividad acumulada de 91.9% y una positividad semanal como lo muestra la **figura 5**. La incidencia de microorganismos en aislamientos virales procesado por FilmArray para el año en curso.

Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 11 y 13, la dinámica de circulación viral muestra un predominio marcado de los virus pertenecientes a la familia Picornaviridae. El Rhinovirus se posiciona como el principal agente etiológico con una proporción de incidencia global del 43.9% ($IC95\% : 38.17 - 49.76$), aunque se observa una tendencia a la disminución progresiva al comparar el primer intervalo (SE 11-10) donde registró un 60.0%, frente al segundo intervalo (SE 12-13) donde descendió al 52.2%. De manera similar, el Enterovirus mantuvo una presencia importante pero con una reducción moderada, pasando de una incidencia semanal del 31.4% a un 26.1%. En contraste con este descenso de los virus predominantes, se advierte un incremento epidemiológicamente relevante de Influenza A, que experimentó un repunte significativo al elevarse de un 5.7% en la medición inicial a un 17.4% en el cierre del periodo, consolidándose como la tercera causa de aislamiento con un total de 32 casos.

Microorganismo	Aislamientos (n)	Prop.Incidencia (%)	IC95% inf	IC95% sup	Sem 11 - 10[a]	Sem 12 - 13[a]
Rhinovirus	122	43.9	38.17	49.76	60.0	52.2
Enterovirus	89	32.0	26.81	37.71	31.4	26.1
Influenza A	32	11.5	8.27	15.80	5.7	17.4
VSR	24	8.6	5.87	12.52	5.7	0.0
Adenovirus	22	7.9	5.28	11.69	2.9	8.7
Parainfluenza Virus (1,2,3)	16	5.8	3.57	9.14	0.0	8.7
Coronavirus	11	4.0	2.22	6.95	0.0	4.3
Influenza AH1N1	9	3.2	1.71	6.04	2.9	0.0
metaneumovirus	3	1.1	0.37	3.12	0.0	4.3
SARS-CoV-2	1	0.4	0.06	2.01	0.0	0.0

[a]Proporción de incidencia sobre las muestras procesadas en el periodo de 2 semanas

Por otro lado, agentes como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y la Influenza AH1N1 mostraron un comportamiento de cese en su detección hacia las semanas 12-13, cayendo ambos a una incidencia del 0.0% tras haber iniciado el periodo con un 5.7% y 2.9% respectivamente. Esta ausencia de detecciones finales contrasta con el comportamiento de otros virus emergentes o estables en la vigilancia, como el Adenovirus, que incrementó su actividad del 2.9% al 8.7%, y el Parainfluenza, que tras un silencio inicial alcanzó una incidencia del 8.7% al cierre del reporte. Finalmente, se identifica una circulación marginal y esporádica de Coronavirus (4.0%), Metaneumovirus (1.1%) y SARS-CoV-2 (0.4%), este último con un único aislamiento registrado, lo que sugiere una baja presión de este patógeno en el perfil epidemiológico actual frente al resto de virus respiratorios estacionales.

1.3 Enfermedades transmitidas por vectores

Para las diferentes enfermedades transmitidas por vectores el reporte de casos para esta semana y su acumulado se presentan en la siguiente tabla:

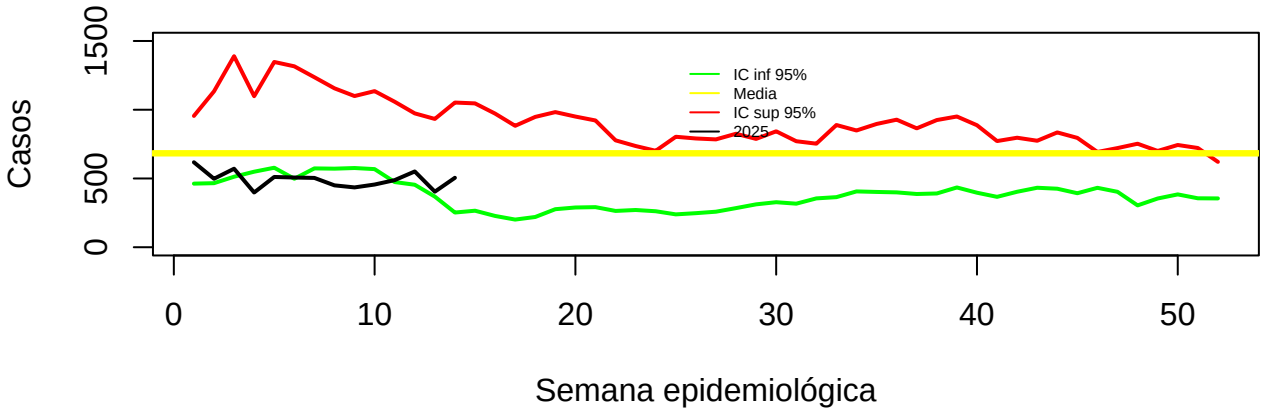
Tabla 2. Comportamiento de la enfermedades transmitidas por vectores, semana epidemiológica 14

Evento	Semana actual	Acumulado
Dengue	2	34
Chinkunguya	0	0
Zika	0	0
Malaria	0	8

Evento	Semana actual	Acumulado

según canal endémico (figura 5) el evento dengue se mantiene en zona de brote para el año actual.

1.4 Infección Diarreica Aguda



2 Eventos de interes en salud pública

2.1 Mortalidad materno-perinatal

En la semana epidemiológica 14 de 2026 se notificaron 1 muertes perinatales; 8 casos acumulados hasta el momento.

2.2 Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia

En la semana epidemiológica 14 de 2025 se notificaron al Sivigila 50 casos de agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia , con un acumulado hasta el momento de 682 casos.

2.3 Tuberculosis

Se notificaron al sistema de vigilancia para esta semana 7 casos de tuberculosis sensible, con un acumulado en el sivigila de 121 casos para TB sensible.

2.4 VIH/SIDA

Se han notificado 11 casos de VIH/SIDA, con un acumulado en el sivigila de 131 casos.

2.5 Sìfilis gestacional y congénita

Para esta semana se notificaron al Sivigila 1 casos de sífilis gestacional, con un acumulado al momento de 20 y casos de sífilis congénita para esta semana no se han notificado hasta el momento.

2.6 Cáncer

Entre los tipos de cáncer objeto de vigilancia en salud pública se encuentra cáncer de mama y cuello uterino. De este evento esta semana se notificaron 4 casos, con un acumulado hasta el momento de 66 casos . En Cáncer en menor de 18 años se han notificado al momento 7

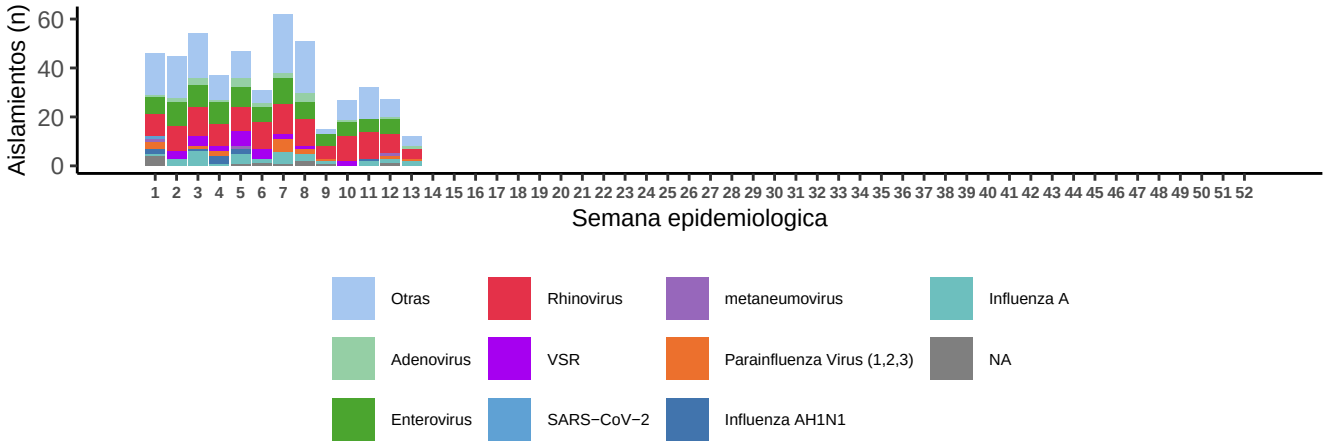


Figura 6: Circulación virus respiratorios, Pereira 2026

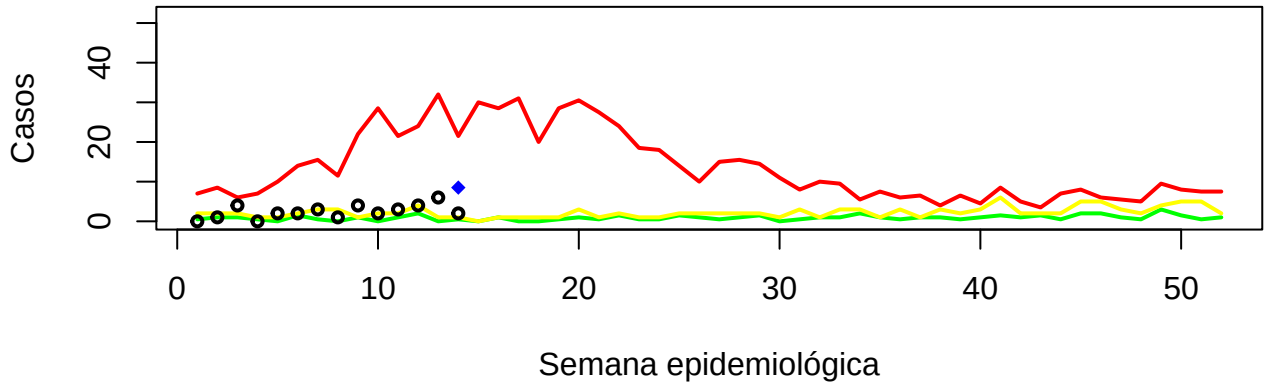


Figura 7: Canal endémico Dengue, Pereira 2026

2.7 Defectos congénitos

Para esta semana epidemiológica 14 de 2025 se notificaron al sistema de vigilancia 4 casos de defecto congénito. El total de casos ingresados hasta el momento son: 30 casos para defectos congénitos.

2.8 Inmunoprevenibles

Frente al evento varicela, para esta semana epidemiológica se notificaron 2 casos, con un acumulado de hasta el momento de 74.

2.9 Virus nuevo (COVID-19)

Durante este año 2026, se han notificado a semana epidemiologica 14 al sistema de vigilancia SIVIGILA un total de 5 casos leves o sin necesidad de hospitalización, para esta ultima semana epidemiologica no hay reporte de casos para COVID leve.

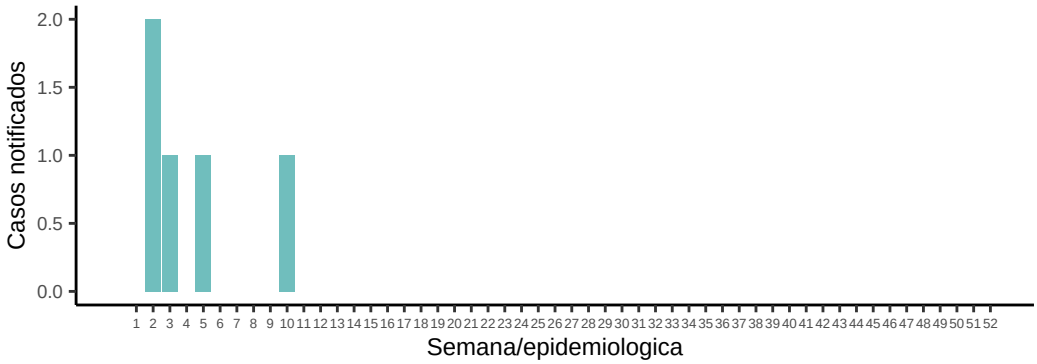


Figura 8: Notificacion semanal COVID-19, Pereira 2026

3 Vigilancia de exantematica

3.1 Vigilancia Varicela en distintos grupos poblacionales

Ante la emergencia en salud publica internacional declarada por OMS por brote multi-pais por viruela simica, se realiza vigilancia de comportamientos inusuales para varicela en diferentes grupos de edad y sexo, en este sentido para semana epidemiologica 14 no se presentan comportamientos fuera de lo esperado para ningun grupo de edad o sexo.

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 14 , Pereira 2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
100	Accidente ofidico	0	0	1.00
113	Desnutrici”n aguda en menores de 5 anos	1	4	0.02
115	Cancer en menores de 18 anos	0	0	1.00
155	Cancer de la mama y cuello uterino	5	4	0.18

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 14 , Pereira 2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
205	Chagas	0	0	1.00
210	Dengue	1	2	0.18
215	Defectos congenitos	4	4	0.20
300	Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia	47	50	0.05
320	Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	0	1.00
330	Hepatitis a	1	0	0.37
340	Hepatitis b, c y coinfeccion hepatitis b y delta	1	5	0.00
342	Enfermedades huerfanas - raras	2	4	0.09
346	Ira por virus nuevo	8	0	0.00
348	Infeccion respiratoria aguda grave irag inusitada	0	0	1.00
352	Infecciones de sitio quirurgico asociadas a procedimiento medico quirurgico	1	0	0.37
355	Enfermedad transmitida por alimentos o agua (eta)	0	1	0.00
356	Intento de suicidio	16	6	0.00
357	Iad - infecciones asociadas a dispositivos - individual	1	0	0.37
365	Intoxicaciones	6	3	0.09
420	Leishmaniasis cutanea	0	0	1.00
450	Lepra	0	0	1.00
455	Leptospirosis	1	2	0.18
465	Malaria	0	0	1.00
535	Meningitis bacteriana y enfermedad meningoc”cica	0	0	1.00
549	Morbilidad materna extrema	6	3	0.09
560	Mortalidad perinatal y neonatal tardia	1	1	0.37
591	Vigilancia integrada de muertes en menores de cinco anos por infeccion respiratoria aguda - enfermedad diarreica aguda y/o desnutricion	0	0	1.00

Cuadro 7: Comportamientos inusuales para los eventos de interes en salud pública notificados, semana epidemiologica 14 , Pereira 2024

Codigo SIVIGILA	Evento	Esperado	Observado	valor p
620	Parotiditis	2	0	0.14
730	Sarampion	0	0	1.00
740	Sifilis congenita	0	0	1.00
750	Sifilis gestacional	2	1	0.27
800	Tos ferina	0	1	0.00
813	Tuberculosis	8	7	0.14
831	Varicela individual	10	2	0.00
850	Vih/sida/mortalidad por sida	7	11	0.05

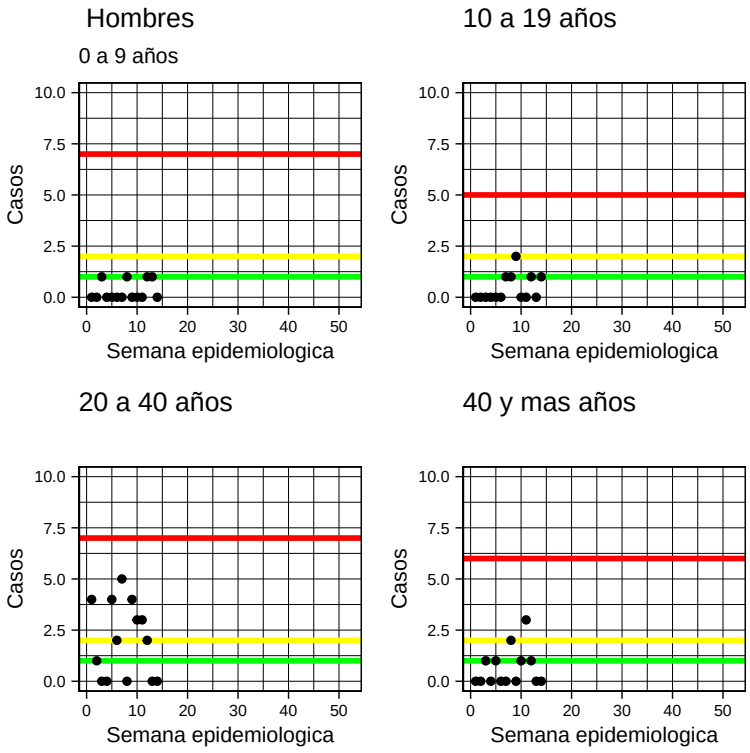


Figura 9: Comportamiento de varicela para Hombres por grupos de edad, Pereira 2026

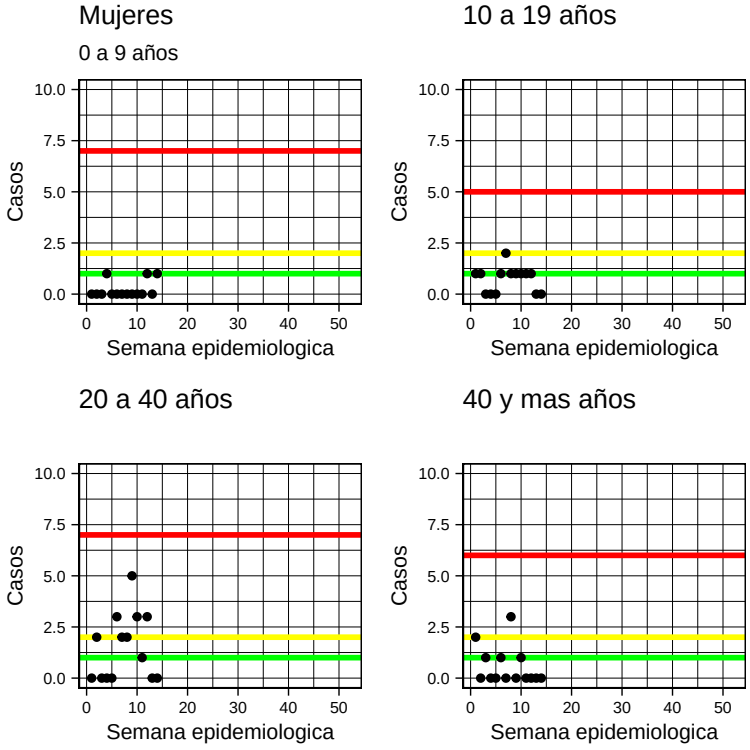


Figura 10: Comportamiento de varicela para Mujeres por grupos de edad, Pereira 2026

Jorge Mario Estrada-Alvarez PhD. MSc. Epi

Coordiandor Eje Estrategico Vigilancia en Salud Pública

Maryluz Hincapie-Acuña MSc. Epi

Baecteriologa Epidemiologa

Viviana Trujillo

Enfermera - SIVIGILA

Angela Monsalve Esp. Epi

Enfermera Epidemiologa

Marla Alexandra Ruiz Esp. Epi

Enfermera Epidemiologa

Alcaldia de Pereira

Secretaria de Salud Pública y Seguridad Social